

Ropa, lavandería y utensilios de aseo

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Mantener separación entre textiles y utensilios limpios y usados durante manipulación, lavado y almacenamiento.

2. Alcance y condiciones de uso

Toallas, sábanas y prendas reutilizables; proveedor externo cuando existe. La ropa desechable se gestiona como residuo según contaminación.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Retirar ropa usada sin sacudir y depositarla en recipiente o bolsa apropiados

Retirar ropa usada sin sacudir y depositarla en recipiente o bolsa apropiados. Separar ropa contaminada según proceso definido y evitar transporte junto a limpio.

2. Identificar área de recepción y lavado o proveedor externo, contención del transporte y re

Identificar área de recepción y lavado o proveedor externo, contención del transporte y responsables. Documentar acuerdo de calidad y evidencia de entrega y recepción cuando se terceriza.

3. Lavar según tipo de tejido, suciedad y proceso compatible; utilizar detergente y ciclo def

Lavar según tipo de tejido, suciedad y proceso compatible; utilizar detergente y ciclo definidos por responsable competente. No imponer temperatura universal ni lavar material clínico con ropa personal sin control.

4. Secar completamente y revisar integridad; retirar prendas deterioradas

Secar completamente y revisar integridad; retirar prendas deterioradas. Plegar en área limpia y guardar protegidas de humedad, polvo y químicos.

5. Limpiar y desinfectar utensilios de aseo según compatibilidad, enjuagar si corresponde y d

Limpiar y desinfectar utensilios de aseo según compatibilidad, enjuagar si corresponde y dejar secos. Evitar almacenamiento húmedo que favorece contaminación.

6. Registrar cargas o entregas, cantidad, novedad y disposición

Registrar cargas o entregas, cantidad, novedad y disposición. Ante mezcla de circuitos repetir procesamiento y corregir separación, capacitación o proveedor.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Circuitos sucio y limpio diferenciados.

Secado completo y almacenamiento protegido.

Proveedor evaluado con evidencia.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Fecha y origen	
Tipo y cantidad de textil	
Condición y separación	
Entrega o ciclo	
Producto y método	
Secado	
Recepción limpia	
Proveedor	
Novedad	
Acción	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Referencia técnica de infección

OMS, Hand hygiene in outpatient and home-based care (2012), estrategia multimodal y cinco momentos. Referencia técnica para adaptación ambulatoria, no reglamento colombiano ni sustituto de etiqueta o fabricante.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241503372>

Residuos

Resolución 591 de 2024, artículos 1-4 y manual anexo; Decreto 780 de 2016, gestión de residuos en atención en salud. Diagnóstico, cantidades, rutas y soportes del gestor deben ser reales.

https://minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No%20591%20de%202024.pdf

Aprobó
Eliana Milena Pardo Ríos
TP 60576